PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Comarca de Nova Friburgo

3ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo

Avenida Euterpe Friburguense, 201, Centro, NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28605-130

Processo: 0803318-65.2025.8.19.0037

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: L. G. L. H.

RÉU: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, com pedido de tutela antecipatória, proposta pela parte autora em face de UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., narrando o autor que, verificada a lentidão no seu crescimento, foram realizados exames que levaram ao diagnóstico de baixa estatura idiopática (CID-10:E34.3) e iniciou o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha de SOMATROPINA (OMNITROPE), conforme laudo médico em anexo.

Aduz que posteriormente solicitou a cobertura do tratamento pelo plano de saúde réu, mas teve o seu requerimento negado, com base em suposta utilização ambulatorial do medicamento e ausência de cobertura pelo rol da ANS.

Prossegue afirmando que não possui condições de continuar custeando tal tratamento, ante o seu elevado custo, e que a referida negativa teria importado em angústia e seria indevida, ensejando a reparação pelos danos morais experimentados pelo autor, bem como quanto aos danos de ordem material.

Diante do quadro narrado, cita a legislação e a jurisprudência que entende aplicáveis ao caso em tela, requerendo, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a fornecer o tratamento indicado, e, ao final, a confirmação da tutela para condená-la a fornecer o mencionado tratamento, sob pena de cominação de multa diária de R$ 2.000,00. Ainda pugna pela condenação da parte ré a indenizar danos morais de R$ 20.000,00 e danos materiais correspondentes aos valores gastos com esse tratamento e eventuais substitutos, além da condenação aos ônus sucumbenciais.

Com a inicial vieram os documentos de índices 185679873/185679874, 185678707/185679870 e 185685126/185685128.

Parecer do MP de índice 188485835, pelo deferimento da tutela de urgência.

Decisão de índice 190089079, deferindo o benefício da gratuidade de justiça e indeferindo o pedido de tutela de urgência, além de determinada a citação da parte ré.

Destaca-se que, interposto recurso de agravo de instrumento pela parte autora em face da decisão de indeferimento da tutela de urgência, houve o indeferimento de tutela recursal e posteriormente tal recurso teve o seu provimento negado, conforme verificado em consulta ao portal do TJRJ.

Neste ínterim, foi apresentada contestação no índice 212437126, a parte ré sustentou (i) a ausência de cobertura obrigatória do tratamento pleiteado por não constar do rol da ANS, à luz da alteração jurisprudencial promovida pelo STJ sobre o tema e da inclusão do §3° ao art. 10-D da lei 9.656/98; e (ii) o descabimento de indenização por danos materiais e morais pela conduta da mesma estar amparada na legislação e eventual inadimplemento contratual não importar em responsabilização. Assim sendo, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica de índice 220708280.

Instadas as partes a se manifestarem em provas, o fez tão somente o réu nos termos da petição de índice 230977684.

Parecer final do órgão ministerial de índice 247474048, em sentido desfavorável à procedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do que consta dos autos, da natureza da demanda e da desnecessidade de outras provas, tenho que o feito se encontra maduro, razão pela qual passo ao seu imediato julgamento.

Inicialmente, é de se observar que a relação jurídica existente entre as partes se qualifica como relação de consumo, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, aplica-se à hipótese dos autos o Enunciado da Súmula n° 608 do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Partindo-se de tal premissa, como sabido, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva e solidária a todos os fornecedores integrantes da cadeia consumerista, nos termos dos artigos 7°, 12, 14 e 25, §1°.

Por conseguinte, também incidirá no presente julgamento toda a concepção principiológica da legislação consumerista, presumindo-se a boa-fé na conduta e nas alegações autorais, na forma do art. 4°, I e III, do CDC.

Além disso, sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor mais benéficas, merecem aplicabilidade a fim de compensar os desequilíbrios contratuais, com fundamento no que estabelece o art. 47 da Lei n° 8.078/90, vedando-se as chamadas "cláusulas abusivas".

Quanto ao cerne da controvérsia propriamente dita, tem-se que o caso concreto em exame versa essencialmente sobre a previsão (ou não) de cobertura obrigatória do medicamento pleiteado pela parte autora e, em caso positivo, sobre a existência de falha na prestação do serviço apta a possibilitar o ressarcimento dos danos materiais e a configuração (ou não) de danos morais.

Pois bem, de acordo com o narrado pela parte autora, em sede vestibular, esta última é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e foi diagnosticada com complicações na produção do hormônio do crescimento e quadro de baixa estatura grave, razão pela qual passou a utilizar SOMATROPINA (OMNITROPE) prescrita pelo médico a acompanha.

Ocorre que, apesar da necessidade do tratamento, a parte ré se negou a fornecê-lo, sob a alegação de ausência de previsão contratual, o que teria causado prejuízos de ordem material e

moral.

Ainda afirma que não dispõe de meios para continuar custeando tal tratamento, razão pela qual não restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda, em que requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a fornecer o tratamento indicado, e, ao final, a confirmação da tutela, sob pena de cominação de multa diária; e a indenizar danos materiais e morais, além da condenação aos ônus sucumbenciais.

Ao revés, a parte ré defendeu, em síntese, que a recusa no fornecimento da medicação teria como justificativa a falta de cobertura obrigatória de acordo com o rol da ANS; e que não pode ser condenada a indenizar os alegados danos por ter observado o prescrito na lei.

Segundo se verifica no caso em tela, em especial, na documentação constante dos autos, a parte autora apresenta quadro de baixa estatura, sendo prescrito pelo médico assistente o medicamento SOMATROPINA, o qual possui registro na ANVISA e consiste em medicamento injetável (no músculo ou sob a pele), de uso domiciliar, também conhecido como hormônio de crescimento.

Trata-se de medicamento incorporado ao e disponível no Sistema Único de Saúde, de acordo com os critérios estabelecidos (Portaria nº 110/SAS/MS, de 2010 - que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Hipopituitarismo [11], CID E23.0), sendo parte do elenco do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja disponibilização é realizada em nível estadual.

Cabe agora analisar se existe obrigação do plano de saúde réu em fornecer esse medicamento, a despeito do parecer do órgão ministerial de índice 178732191, no bojo do qual se opinou em sentido favorável ao seu fornecimento.

Pois bem, dispõe o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art.

12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;".

Já o art. 12 da mesma lei somente obriga aos planos privados de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, em caso de tratamento com antineoplásico e seus efeitos adversos. Confira-se:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar".

Confira-se, ademais, o que dispõe o art. 17, parágrafo único, VI, da RN ANS 465/2021:

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e mergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;"

Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

É, pois, lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente

externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim, na correta exegese dos arts. 10, VI; 12, I, c; 12, II, g, da Lei nº 9.656/1998, bem assim art. 17, parágrafo único, VI, da RN ANS nº 465/2021.

Contudo, as previsões legais acima citadas não impedem a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde; ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS - hipóteses, entretanto, não incidentes ao caso concreto.

Como sabido, o dever de prestar assistência à saúde de forma ampla e irrestrita foi constitucionalmente assumido pelo Estado, não havendo como se imputar tal responsabilidade a entidades privadas e no âmbito da assistência suplementar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.692.938/SP, fixou o entendimento, segundo o qual os planos de saúde não são obrigados a fornecer os medicamentos em sede domiciliar, com exceção dos antineoplásicos, da medicação assistida e dos incluídos no rol da ANS, com base no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e artigo 19, § 1º, VI, da Resolução Normativa nº 338/2013, atual artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e

correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido". (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)".

Embora o medicamento pleiteado seja injetável, permanece sendo de uso domiciliar. Apenas os medicamentos que necessitam de supervisão de profissional habilitado para a aplicação é que constituem exceção ao precedente acima, conforme se depreende abaixo:

"*AGRAVO* INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de

unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 3. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.747.463/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)".

Ainda sobre o tema, cito decisão que se aplica expressamente ao presente caso, oriunda deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ A FORNECER O MEDICAMENTO "SOMATROPINA" (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. MEDICAMENTO INJETÁVEL DE USO DOMICILIAR, QUE TEM REGISTRO APROVADO. MEDICAMENTO INCORPORADO E DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS (PORTARIA Nº 110/SAS/MS, DE 2010 - QUE APROVOU O PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA O HIPOPITUITARISMO, CID E23.0), SENDO PARTE DO ELENCO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CUJA DISPONIBILIZAÇÃO É REALIZADA EM NÍVEL ESTADUAL. É LÍCITA A EXCLUSÃO, NA SAÚDE SUPLEMENTAR, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998 E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA RN ANS Nº 465/2021. OS MEDICAMENTOS RECEITADOS POR MÉDICOS PARA USO DOMÉSTICO E ADQUIRIDOS COMUMENTE EM FARMÁCIAS NÃO ESTÃO, EM REGRA, COBERTOS PELOS PLANOS DE SAÚDE. A PREVISÃO LEGAL DO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998 NÃO IMPEDE A OFERTA DE MEDICAÇÃO DE

USO DOMICILIAR PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (I) POR LIBERALIDADE; (II) POR MEIO DE PREVISÃO NO CONTRATO PRINCIPAL DO PRÓPRIO PLANO DE SAÚDE OU; (III) MEDIANTE CONTRATAÇÃO ACESSÓRIA DE CARÁTER FACULTATIVO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA RN Nº 310/2012 DA ANS - HIPÓTESES NÃO INCIDENTES AO CASO CONCRETO. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSUMIDO PELO ESTADO. NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA É ORIENTADA PELA POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (PNM), QUE GARANTE O ACESSO DE FÁRMACOS À POPULAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE OS DE ALTO CUSTO, POR MEIO DE INSTRUMENTOS COMO A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 0023376-09.2021.8.19.0023, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 31/08/2023)

Vale ainda destacar que, recentemente, este Tribunal ratificou o decidido no julgado supracitado ao reforçar, em hipótese semelhante a ora em tela, que o tratamento pretendido pela parte autora através da presente demanda possui natureza domiciliar e não se encontra coberto pelos planos de saúde:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DESAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LEGÍTIMA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento, pela operadora de saúde, do medicamento prescrito à parte autora para tratamento de sua deficiência de hormônio do crescimento. 2. Ausência dos requisitos autorizadora para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 3. Incontroverso que a agravante é menor de idade, usuária do plano de saúde operado pela ré/agravada, e foi diagnosticada com deficiência de hormônio do crescimento, tendo sido indicado o tratamento com uso dos medicamentos Genotropin 12mg (SOMATROPINA). 4. Contudo, o tratamento pleiteado consubstancia-se em tratamento de uso domiciliar, que não é de fornecimento obrigatório pela lei de regência, vide o disposto no artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98. 5. Portanto, o tratamento pleiteado se resume ao fornecimento de medicação que pode ser adquirida em farmácia pela própria autora, não havendo prescrição de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. 6.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico, e adquiridos comumente em farmácias, não estão cobertos pelos planos de saúde, com exceção dos antineoplásicos orais(e correlacionados). 7. Decisão que não se mostra teratológica nem contrária às provas nos autos. Incidência do teor da súmula nº 59 deste Tribunal de Justiça. 8. Manutenção do decisum que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO, por maioria." (TJ-RJ – APL: 0062205-26.2024.8.19.0000 - Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14.04.2025, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

É de se esclarecer, por fim, que o decidido pelo STF, no julgamento da ADI 7.265, quanto aos critérios a serem preenchidos para a disponibilização de tratamento não incluído no rol da ANS, salvo entendimento em sentido diverso, não se aplica ao caso em questão, eis que, como já dito, o medicamento pretendido é de uso domiciliar e não faz parte das hipóteses excepcionais, a saber, antineoplásicos.

Dessa forma, tenho que, por mais que se lamente a situação narrada nos autos, a parte ré não se encontra(va) obrigada a fornecer o medicamento prescrito por ter sido receitado, conforme já dito, para uso doméstico e adquirido em farmácias, bem como por inexistir previsão contratual para cobri-lo, desincumbindo-se do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, por ter trazido aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora.

Acerca do pedido de ressarcimento dos danos materiais, consubstanciados nos valores despendidos com a aquisição do medicamento pleiteado nos autos em questão, tenho que, como a negativa do plano de saúde réu foi legítima, se encontra respaldada na ausência de cobertura obrigatória de fornecimento do mesmo e na falta de previsão contratual que lhe garanta a disponibilização, este não merece prosperar, devendo ser julgado improcedente.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que outra sorte não lhe assiste, eis que se a parte ré não era obrigada a cobrir o tratamento prescrito à autora, não há dano a ser reparado.

Há de ser ressaltado, por derradeiro, que caberia à parte autora a demonstração de elementos suficientes para a comprovação do FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, como bem observado na Súmula 330 deste E. Tribunal e que dispõe:

Nº. 330 "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

Pelo dito, tenho que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários de advogado que fixo em R$ 800,00, observada eventual gratuidade de justiça.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado da sentença, certificado o correto recolhimento das custas, dê-se baixa e arquivem-se.

NOVA FRIBURGO, 13 de janeiro de 2026.

FERNANDO LUIS GONCALVES DE MORAES
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: FERNANDO LUIS GONCALVES DE MORAES
13/01/2026 14:02:01
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

26011314020185100000243212104

IMPRIMIR GERAR PDF